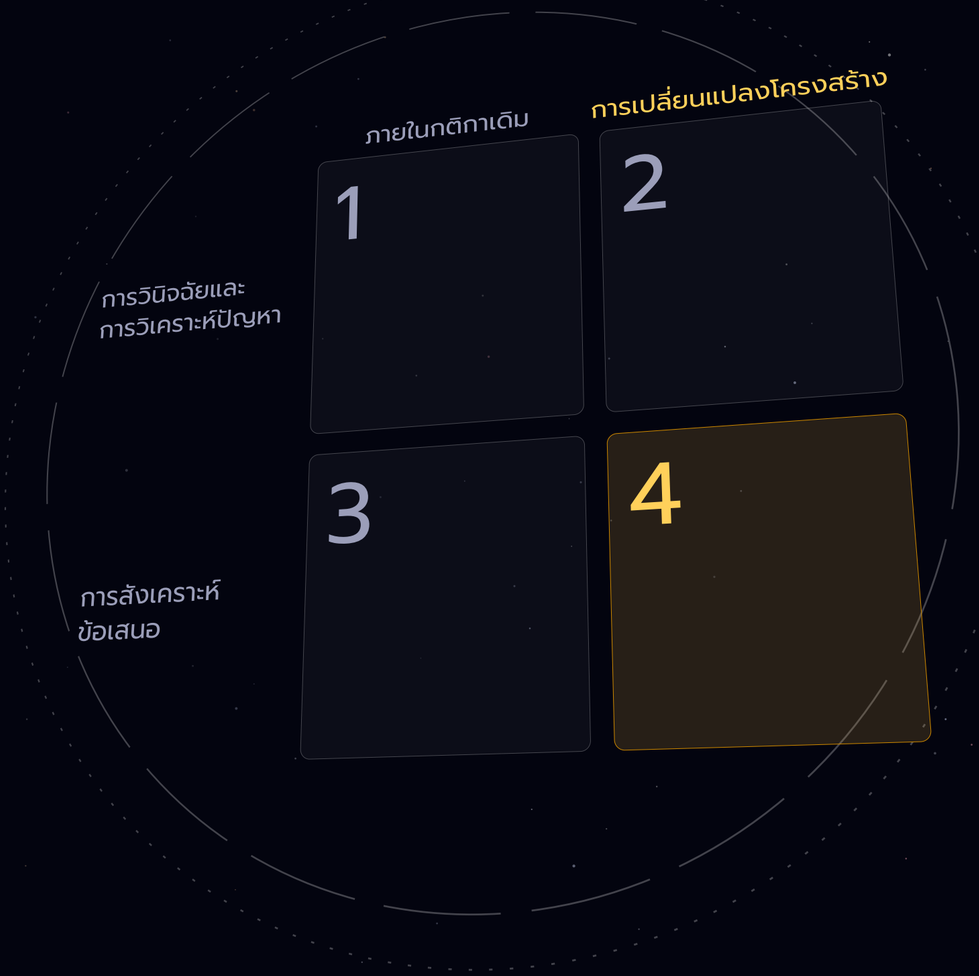
การประชุมนำเสนอผลการศึกษาและเสวนานโยบาย · 26 ตุลาคม 2569

ผลที่คงทนที่สุด ชี้ออกนอกกรอบ

ว่าด้วยก้าวต่อไปของการสร้างองค์ความรู้และบทบาทของนักวิชาการ
ในการสนับสนุนการจัดสรรทรัพยากรสาธารณสุข

ผศ.ดร.นพ.สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์
หน่วยวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล



101 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

สิ่งที่ได้ยินจากวงเสวนา · การตีความของคณะวิจัย

ความเห็นต่างไม่ได้อยู่ที่ตัวเลข แต่อยู่ที่คำถามที่แต่ละคนถาม

1 ความจำเป็นใดควรถูกนับก่อน

2 ใครควรเป็นผู้จ้าง และอะไรกำหนดว่าพื้นที่รับคนได้เท่าใด

3 ใครรับภาระของความไม่เพียงพอ ระหว่างรัฐ ผู้ทำงาน ครอบครัว และชุมชน

4 ใครควรมีสิทธิ์ตัดสินว่าเท่าใดจึงเพียงพอ และฉันทามติควรสร้างผ่านช่องทางใด

101 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

การตีความของคณะวิจัย

งานที่เคร่งครัดภายในกติกาเดิมบอกได้ว่า เครื่องมือหยุดทำงานตรงไหน

การศึกษานี้ตั้งคำถามส่วนใหญ่ภายในกติกาเดิม และคำตอบภายในกติกาเดิมมีคุณค่าในตัวเอง แต่เมื่ออ่านผลทุกส่วนร่วมกัน ผลที่คงทนที่สุดหลายข้อชี้ไปยังข้อจำกัดที่กติกาเดิมไม่ได้เปิดให้เปลี่ยน

ผลเหล่านี้ไม่ได้แสดงว่าการศึกษาภายในกติกาเดิมผิดทาง ตรงกันข้าม มันคือผลผลิตของการศึกษาภายในกติกาเดิมที่ทำอย่างเคร่งครัด



- กรอบเต็มแล้ว ทุกหลักคิดให้ 0.337
- วางตำแหน่งถูกที่ = เพิ่ม 2.0 เท่า
- ใครจ่าย: 0.396 เทียบ 0.488
- 8 จังหวัดต่ำทุกไม้บรรทัด
- แพทย์เฉพาะทาง 63.5% อยู่ในสถานพยาบาลหนึ่งในสิบที่มีแพทย์เฉพาะทางมากที่สุด
- ผู้ตอบ 43% เป็นผู้ดูแลหลักในครอบครัว

ผลที่คงทนที่สุดชี้ไปนอกกติกาที่เปลี่ยนได้ในรอบการจัดสรร

101 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

หนึ่ง · ความรู้สี่ช่อง

แผนภาพเชิงแนวคิด

สี่ช่องของความรู้ แบ่งด้วย**สองแกน**

แกนแรกแยก**การวินิจฉัยและการวิเคราะห์ปัญหา** คือการอธิบาย ว่าเกิดอะไรขึ้นและเพราะอะไร ออกจาก**การสังเคราะห์ข้อเสนอ** ว่าควรทำอะไร แกนที่สองแยกงาน**ภายในกติกาเดิม** ซึ่งรับกติกา วินัย และแหล่งข้อมูลที่มีอยู่เป็นเงื่อนไข ออกจากงานที่มุ่ง **การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง**ของกติกาเหล่านั้น

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในที่นี้คือความหมายของคำว่า Radical ตามรากศัพท์ คือ**การแตะถึงราก** ไม่ใช่ความสุดโต่ง และกรอบสี่ช่องไม่ได้ขอให้เลือกคอลัมน์ใด แต่ถามว่าสองคอลัมน์ส่งงานให้กันอย่างไร



Lindblom · ปรับทีละน้อย เปรียบเทียบทางเลือกที่ใกล้กัน

Etzioni · กวาดตาแบบผสม: สำรวจทางเลือกพื้นฐานอย่างกว้าง แล้วลงมือทีละขั้น

ดัดแปลงจากการนำเสนอของ Geoff Mulgan ในการประชุม SPA Conference 2026 · Lindblom 1959 · Etzioni 1967 · รายงานการศึกษา บทที่ 11

101 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

การตีความของคณะวิจัย

งานนี้อยู่ช่องไหน: หนักที่หนึ่งและสาม ช่องที่สี่แทบว่าง

การนับ การทดสอบตัวหาร การกระทบยอดการไหล และการสำรวจกำลังคน เป็นการวิเคราะห์ปัญหาภายในกติกาเดิม ส่วนแบบจำลองจัดสรรและชุดมาตรการการธำรงคนในระบบ เป็นข้อเสนอภายในกติกาเดิม

นี่คือลักษณะทั่วไปของงานวิจัยนโยบายที่รับทุนตามวัตถุประสงค์ ตำแหน่งนี้ไม่ได้ลดคุณค่าของผล แต่กำหนดว่าผลรองรับข้ออ้างชนิดใด

> “การศึกษาครั้งนี้กล่าวได้ว่าภายใต้กติกาที่สมมติ ทางเลือกใดให้ผลอย่างไร แต่ยังกล่าวไม่ได้ว่าการเปลี่ยนกติกาใดจะให้ผลดีกว่า และต้องแลกด้วยอะไร”
>
> รายงานการศึกษา บทที่ 11

	ภายในกติกาเดิม	การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
การวินิจฉัยและการวิเคราะห์ปัญหา	**1** ● นับแพทย์และเทียบหลายตัวหาร ● กระทบยอดการไหลเข้าและออก ● สำรวจว่าทำไมคนอยู่หรือออก วิเคราะห์ปัญหาภายในกติกาเดิม	**2** ● ถามว่าใครนิยามความขาดแคลน ● ถามว่าวิชาชีพกำหนดจำนวนอย่างไร ● ถามว่าภาระดูแลถูกผลักไปที่ใคร วิเคราะห์ปัญหาเชิงโครงสร้าง
การสังเคราะห์ข้อเสนอ	**3** ● จำลองการจัดสรรแพทย์ใหม่ ● เสนอชุดมาตรการธำรงคนในระบบ ข้อเสนอภายในกติกาเดิม	**4** ● เสนอวงจรทบทวนกติการายปี เกือบว่าง ข้อเสนอเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

101 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

สอง · ทำไมช่องที่สี่ | การตีความของคณะวิจัย

ทำไมช่องที่สี่ควรมาก่อน และมีเงื่อนไขอะไร

เมื่อปัญหาอยู่ในการจัดการเชิงโครงสร้าง ความรู้เพิ่มในช่องที่สามให้ผลตอบแทนลดลง เพราะมันปรับได้เพียงภายในขอบที่โครงสร้างกำหนด

แต่ความสำคัญนี้มีเงื่อนไข ข้อเสนอเชิงโครงสร้างต้องได้หลักฐานกลไกจากช่องที่หนึ่ง คำถามว่าใครได้ใครรับต้นทุนจากช่องที่สอง และขั้นทดลองที่มีจุดตรวจจากช่องที่สาม ถ้าขาดสามสิ่งนี้ **ช่องที่สี่จะเป็นวิสัยทัศน์ที่ตรวจไม่ได้**

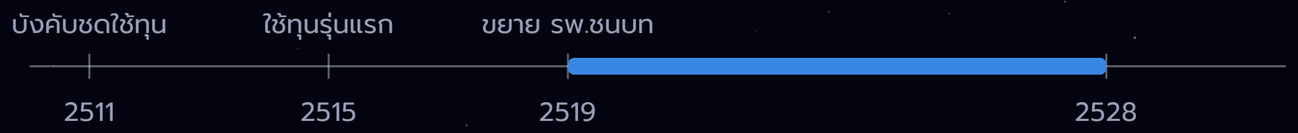
เหตุผลที่หนึ่ง · ผลของการศึกษาชี้ไปที่นั่น

กรอบคือสูตร	ไม่มีตำแหน่งรองรับ	ต่ำทุกไม้บรรทัด
0.337 ทุกหลักคิด	8,272 คน*	8 จังหวัด

* แพทย์พร้อมจัดสรรปีละสองพันห้าร้อยคน กรอบโตร้อยละห้าต่อรอบ

เหตุผลที่สอง · เวลา: "สังคมจะเลือกโดยไม่รู้ว่ากำลังเลือก"

เหตุผลที่สาม · ประวัติศาสตร์ไทย: การเปลี่ยนที่สำคัญมาจากทางเลือกเชิงโครงสร้าง



รพ.ชนบท 200 → 425 แห่ง

แพทย์ชนบท 300 → 1,162 คน

อีสาน/กทม. 21 เท่า → 8.6 เท่า

เงื่อนไข · ช่องที่สี่ต้องได้งานจากอีกสามช่อง

หลักฐานกลไก ← ช่องที่หนึ่ง

ใครได้ ใครรับต้นทุน ← ช่องที่สอง

ขั้นทดลองที่มีจุดตรวจ ← ช่องที่สาม



101 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

สอง · ทำไมช่องที่สี่ | การตีความของคณะวิจัย

หกแผนงานวิจัยในระดับชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ

แต่ละแผนเริ่มจากข้อจำกัดที่ผลของการศึกษาชี้ ระบุทางเลือกที่จะเปลี่ยนข้อจำกัดนั้น และบอกว่าต้องได้งานใด จากช่องอื่นก่อนเสนอผลได้

ⓘ ทั้งหมดเป็นข้อเสนอของคณะผู้เขียน ยังไม่ใช่วาระที่หน่วยงานใดรับแล้ว

1 ระบบดูแลระดับพื้นที่ หลังการกระจายอำนาจ

ชุมชน

การกำกับและการเงินแบบใดรักษาทีมปฐมภูมิและเส้นทางอาชีพข้ามนายจ้างได้

รพ.สต. ในตัวอย่าง 39 จาก 76 แห่งถ่ายโอนแล้ว

2 การผลิตจากพื้นที่ ที่ผูกกับเส้นทางอาชีพ

ชุมชนและเศรษฐกิจ

รับผู้เรียนจากพื้นที่ แหล่งฝึกในภูมิภาค และบันไดอาชีพช่วยธำรงคนไว้ในพื้นที่ได้เพียงใด

บ้านเกิดผูกคนไว้กับพื้นที่ (ออดส์ 0.44) ไม่ใช่กับสังกัด

3 ระบบการจ้าง และกรอบตำแหน่งตามพันธะบริการ

เศรษฐกิจและรัฐ

รูปแบบการจ้างแบบใดเปลี่ยนการกระจาย ความมั่นคง และต้นทุน

ใครจ่าย: 0.396 เทียบ 0.488

4 พันธะสาธารณะ ของบริการเอกชนและการทำงานสองภาค

เศรษฐกิจ

ระบบหลักประกันและเงื่อนไขอนุญาตทำให้เอกชนรับผิดชอบพื้นที่ขาดได้หรือไม่

แพทย์เฉพาะทาง 63.5% อยู่ในสถานพยาบาลหนึ่งในสิบที่มีมากที่สุด

5 เศรษฐกิจการดูแล และการสนับสนุนผู้ดูแล

สังคมและเศรษฐกิจ

ผู้ดูแลชุมชนที่ได้ค่าตอบแทน การพักทดแทน และการดูแลระยะยาว เปลี่ยนภาระอย่างไร

ผู้ตอบ 43% เป็นผู้ดูแลหลักในครอบครัว

6 การตัดสินร่วม เรื่องความเพียงพอและฐานจัดสรร

สังคม

กระบวนการตัดสินร่วมที่ใช้แบบจำลองเปิด เปลี่ยนเกณฑ์และการยอมรับผลอย่างไร

หลักคิดต่างกัน แพทย์ใหม่จังหวัดเดียวต่าง 499 คน

101 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

สาม · ทำให้ตรวจได้ ⬚ แผนภาพเชิงแนวคิด

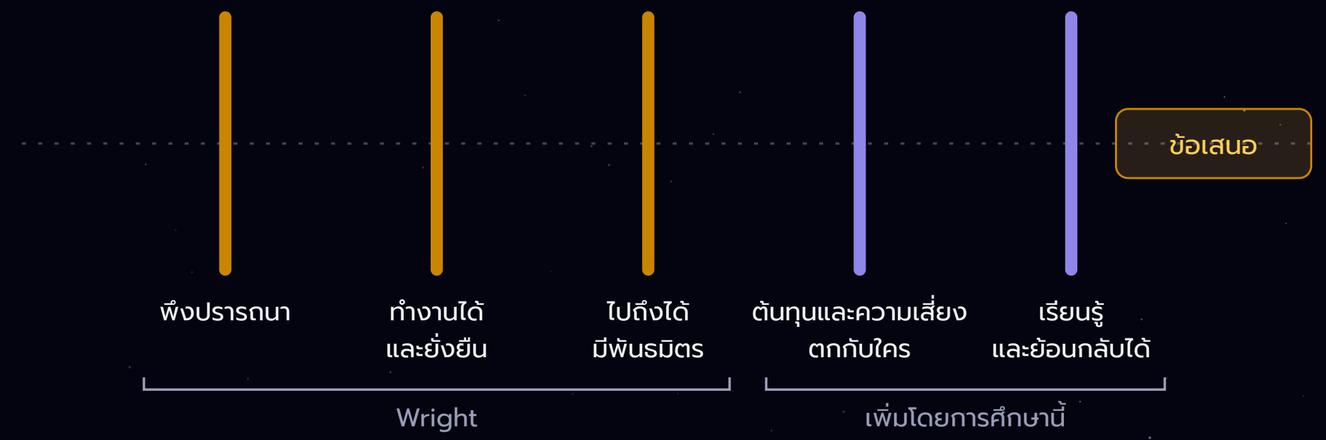
ทำให้ข้อเสนอเชิงโครงสร้าง ตรวจได้

ข้อเสนอเชิงโครงสร้างต้องการเกณฑ์ที่ต่างจากการประเมินมาตรการทั่วไป เพราะมันเปลี่ยนเงื่อนไขที่การประเมินแบบเดิมรับไว้เป็นค่าคงที่

ข้อเสนอเชิงโครงสร้างยังต้องเชื่อมระยะยาวกับระยะสั้น
ด้วยการกวาดตาแบบผสม คือมองทุกทางเลือกพื้นฐานอย่างกว้างทุกห้าปี

แล้วตามทิศที่เลือกทีละปีพร้อมจุดตรวจ จนกว่าจะมีหลักฐานจากการเปลี่ยนจริง
ฉากทัศน์ที่สมมติการเปลี่ยนระบบการจ้าง
ควรถูกเรียกว่า**การทดลองทางความคิดภายใต้เงื่อนไข**

ห้าคำถามที่ทุกข้อเสนอเชิงโครงสร้างต้องตอบ



การกวาดตาแบบผสม (Etzioni) · กล้องสองตัวทำงานคู่กัน

กล้องมุมกว้าง · ทุกห้าปี
เห็นทุกทางเลือกพื้นฐานแบบหยาบ แล้วเลือกทิศ

กล้องซูม · ทุกปีในทิศที่เลือก



101 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

สาม · ทำให้ตรวจได้ | การตีความของคณะวิจัย

ระหว่างรอช่องที่สี่ วาระที่เริ่มได้ทันทีในสามช่อง

งานในสามช่องแรกควรถูกออกแบบให้ส่งหลักฐานที่ช่องที่สี่ต้องใช้ ข้อมูลที่ตอบคำถามจัดสรรรอบหน้าได้ และใช้ประเมินการเปลี่ยนกติกาในอนาคตได้ด้วย ควรได้รับความสำคัญก่อน

ช่องที่ 1 วิเคราะห์ปัญหาภายในกติกาเดิม	ช่องที่ 2 วิเคราะห์ปัญหาเชิงโครงสร้าง	ช่องที่ 3 ข้อเสนอภายในกติกาเดิม
กระทบยอดจำนวนแพทย์ สป. กับแฟ้มเหตุการณ์เข้าออก	ใครกำหนดกรอบอัตรากำลังด้วยเหตุผลและข้อมูลใด	จัดสรรรอบหน้าด้วยหลายเกณฑ์
เชื่อมระเบียนรายบุคคลแบบนิรนาม	ใครผลิตตัวเลขความขาดแคลนเพื่อขอทรัพยากรชนิดใด	วางตำแหน่งใหม่ตามความจำเป็นทุกรอบกรอบ
วัดเวลาทำงานจริง: ผู้ตอบ 34% คิดเกษียณก่อนกำหนดหรือลดชั่วโมงทำงาน	ตลาดเอกชนกับงานดูแลในครัวเรือนดึงคนออกจากพื้นที่ขาดอย่างไร	ส่งแพทย์ใหม่ทุกปีจากตำแหน่งว่างจริง
เก็บหลักฐานจากผู้ที่ออกแล้ว		ประกาศกลุ่ม เวลาเริ่ม และผลที่จะวัดไว้ล่วงหน้า งานปกติจึงกลายเป็นการทดลอง

4 ทุกงานในสามช่องนี้ส่งหลักฐานให้ช่องที่สี่

101 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

สี่ · บทบาทของนักวิชาการ ◐ การตีความของคณะวิจัย

นักวิชาการในช่องที่สี่ไม่ใช่ผู้ออกแบบสังคมแทนผู้อื่น แต่ทำให้ทางเลือกเปิดสู่การตรวจและการโต้แย้ง

	ภายในกติกาเดิม	การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
การวินิจฉัยและการวิเคราะห์ปัญหา	1 งานวิชาชีพ	2 งานวิพากษ์ ใช้เพื่อเปิดความเข้าใจ
การสังเคราะห์ข้อเสนอ	3 งานนโยบาย ใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้า	4 งานสาธารณะ ใช้เพื่อเปิดความเข้าใจ

บทบาท	สิ่งที่ให้	ความเสี่ยงเมื่อทำลำพัง	หลักปฏิบัติ
1 ผู้วิเคราะห์และผู้ดูแลข้อมูล	ตัวเลขที่ระบุขอบเขต ตัวหาร และความไม่แน่นอน	ถือนิยามของผู้จัดเก็บเป็นความจริง	ประกาศขอบเขตและการกระทบยอด รายงานส่วนที่อธิบายไม่ได้
2 ผู้วิพากษ์	ข้อจำกัดที่ถูกทำให้ดูเป็นธรรมชาติ และผู้ที่รับต้นทุน	หยุดที่อรรถาธิบาย ไม่ทดสอบ	ระบุกลไก ผู้กระทำ และผลที่สังเกตได้ ยอมปรับเมื่อหลักฐานไม่สนับสนุน
3 ที่ปรึกษานโยบาย	ทางเลือกที่ใช้ได้ในรอบตัดสิน พร้อมผลที่แลกกัน	ตอบคำถามผู้ว่าจ้างโดยไม่ถามว่าคำถามถูกตั้งอย่างไร	แยกระดับหลักฐาน ประกาศเกณฑ์ล่วงหน้า รายงานผลไม่ผ่าน เปิดเผยแหล่งทุน
4 ผู้ร่วมสร้างทางเลือกกับสาธารณะ	ทางเลือกระยะยาวที่ตรวจได้ด้วยเกณฑ์ที่เปิดเผย	เสนอแทนผู้อื่น หรือใช้ความน่าเชื่อถือทางวิชาการรับรองอุดมการณ์	ใช้เกณฑ์ห้าข้อ ทำงานร่วมกับผู้ทำงาน ผู้ดูแล และชุมชน บันทึกความเห็นต่าง

Burawoy · งานสี่แบบตามชนิดความรู้และผู้ฟัง

Weiss · การใช้งานวิจัยสองแบบ

Weiss 1979 · Burawoy 2005 · รายงานการศึกษา บทที่ 11 ตารางบทบาทของนักวิชาการ

101 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

ความใกล้ชิดกับผู้ตัดสินในบริบทไทย

ความใกล้ทำให้ความรู้ไปถึงการตัดสินได้เร็ว และเป็นส่วนหนึ่งของคำอธิบายความสำเร็จหลายเรื่อง
แต่ก็มีความเสี่ยงที่ต้องจัดการ

หลักปฏิบัติเหล่านี้ไม่ได้ทำให้การศึกษาปราศจากความเอนเอียง แต่**ทำให้ผู้อื่นเห็นว่าความเอนเอียงอาจอยู่ที่ใด**

Harris · การยึดรัฐเพื่อการพัฒนา
เครือข่ายข้าราชการนักปฏิรูประดมทรัพยากร
จนสถาปนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

Selway · กติกาการเลือกตั้งและพรรค
ขบวนการวิชาชีพจำเป็น
แต่การเมืองเชิงสถาบันชี้ขาดมากกว่า

ความเสี่ยงของความใกล้ชิด

- วาระวิจัยถูกกำหนดด้วยคำถามที่หน่วยงานถามได้ภายในอำนาจของตน
- ผู้สร้างความรู้กับผู้ตัดสินเป็นเครือข่ายเดียวกัน การตรวจจากภายนอกอ่อน
- ผู้ที่อยู่นอกเครือข่ายไม่มีช่องทางโต้แย้งเกณฑ์ที่ถูกเลือก

A4R ใช้กับนักวิชาการด้วย

- **เปิดเผย**เหตุผล
- เหตุผลต้อง**เกี่ยวข้อง**
- มี**ช่องทางอุทธรณ์**
- มี**กลไกกำกับ**

สิ่งที่การศึกษาครั้งนี้ทำแล้ว

- ✓ ประกาศเกณฑ์ตรวจแบบจำลองก่อนรันและรายงานผลที่ไม่ผ่าน
- ✓ กำหนดผลลัพธ์หลักของการสำรวจก่อนคำนวณ
- ✓ ปรับสถานะข้อเสนอเรื่องภาระงานที่ข้อมูลไม่สนับสนุน
- ✓ เปิดโค้ดและเครื่องมือทดลองให้ผู้อื่นตรวจ
- ✓ แยกข้อมูลรายบุคคลออกจากผลที่เผยแพร่

101 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

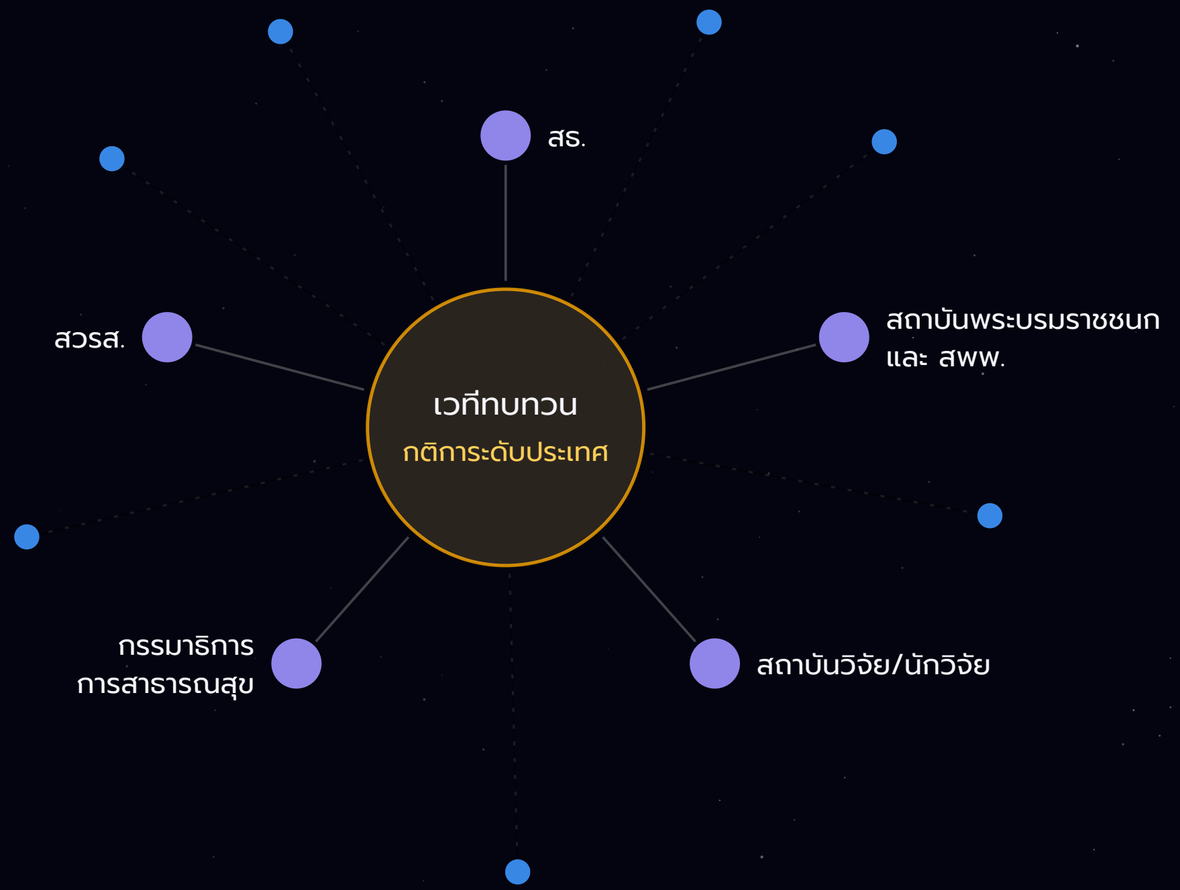
ปิด · การตีความของคณะวิจัย

สร้างสถาบันของความรู้ ข้อเสนอความร่วมมือเพื่อหารือ

งานในช่องที่สี่ต้องใช้ข้อมูลระยะยาว รุ่นติดตาม และผู้วิเคราะห์ในระดับพื้นที่ ซึ่งไม่เกิดจากโครงการวิจัยครั้งเดียว

- **สธ.** ข้อตกลงข้อมูลเพื่อกระทบยอดจำนวนตั้งต้นและเชื่อมระเบียนแบบนิรนาม
- **สถาบันพระบรมราชชนก และ สพพ.** ติดตามรายรุ่นของผู้จบจากโครงการผลิตเพื่อพื้นที่
- **สถาบันวิจัย/นักวิจัย** วิธีวิเคราะห์เชิงสาเหตุและแบบจำลองการเลือกของบุคลากร
- **กรรมาธิการการสาธารณสุข** เวทีติดตามการใช้หลักฐานในกระบวนการนโยบาย
- **สวรส.** เครือข่ายนักวิจัยและหน่วยงานระยะยาว

ⓘ *ข้อเสนอเพื่อหารือ ยังไม่ใช่ข้อตกลงกับหน่วยงานใด*

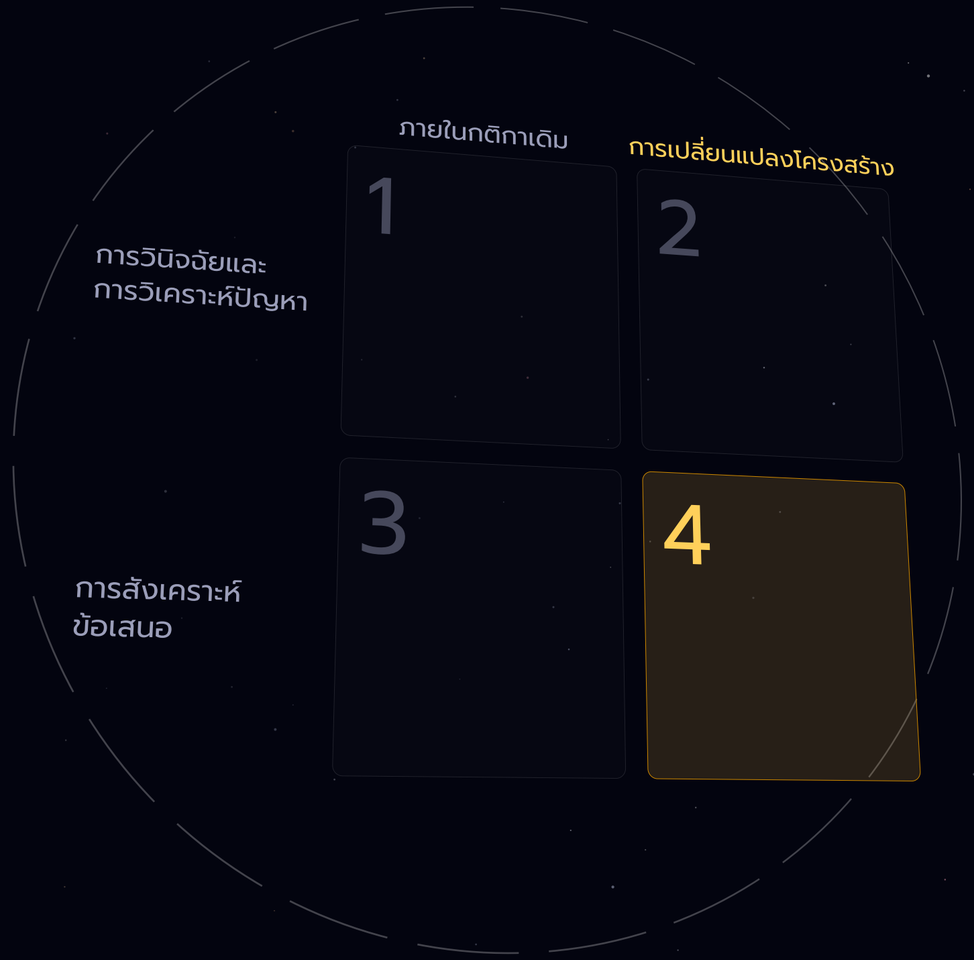


จุดฟ้า: ผู้วิเคราะห์ระดับเขตและจังหวัด · จุดทอง: ผลการทดลองที่ส่งกลับสู่เวทีทบทวน (Ostrom)

101 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

ข้อความปิด | การตีความของคณะวิจัย

แบบจำลอง ไม่ได้ตัดสินใจแทนเรา แต่ทำให้ราคาของแต่ละทางเลือกปรากฏชัด



บทบาทของนักวิชาการคือทำให้การเลือกนั้นตรวจสอบได้
และเรียนรู้ต่อได้ทุกปี เพื่อให้ข้อเสนอรอบหน้ากล้าถามคำถามที่ใหญ่ขึ้น
โดยยังรักษาความสามารถในการตรวจไว้ได้

ขอบคุณสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข คณะวิจัย ผู้ร่วมเสวนา และทุกท่าน

101 ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)